ST. LUKE'S ICU ／ EXECUTIVE SUMMARY

PADIS（鎮痛・鎮静・せん妄） — 要約

解説「PADIS — 鎮痛・鎮静・せん妄」の要点を絞った2ページ版。「詳しく」から本編へ。

聖路加国際病院 集中治療科 ／ 対象：研修医・専攻医・看護師 ／ 最終更新 2026-10-09

1 持ち帰る3点

詳しく

鎮静薬より先に鎮痛

不穏には痛み→不快→覚醒度→せん妄の順に測る

鎮静は深さと時間

薬の名前ではない。RASS −2〜0を毎日測り、浅さはバンドルで保つ

せん妄は予防と原因の是正

抗精神病薬は危険な興奮の短期コントロールだけ。中止条件をセットで

2 3つは1つの管理 — 測る順番を固定する

詳しく

不穏のコール：痛み（NRSかCPOT/BPS）→ 不快（体位・チューブ・口渇・便秘・尿閉）→ 覚醒度（RASS）→ せん妄（CAM-ICU）→ 呼吸

物差し

- 話せればNRS、話せなければCPOT（3点以上で鎮痛を考える）かBPS
- RASSは4時間ごと、目標−2〜0。呼吸努力は測っていない
- RASS −3以上を通ってからCAM-ICUかICDSC。実臨床のCAM-ICU感度は80%

陽性は原因検索の入口

- まず低血糖・高血糖・高CO_2・高Na・ミダゾラムの蓄積・セフェピムの神経毒性
- 続けて低酸素・感染・電解質・尿閉・便秘・疼痛・眼鏡や補聴器
- 鎮静を止めて48時間覚めなければMRIと脳波

- **深鎮静には請求書がつく**：妄想的記憶（38.5%）があるとPTSD症状は3か月6.7%→12か月18.1%。完全健忘でもPTSDは減らない
- **せん妄は脳の臓器障害**：人工呼吸とショックの48%。多数派は見逃されやすい低活動型。BRAIN-ICUでは退院3か月後の26%がアルツハイマー病相当の認知機能。最多の表現型は鎮静薬関連（せん妄日の63%）

3 鎮痛 — 鎮静より先に、処置の前に、時刻表で

詳しく

- **非薬物の介入を時刻表で**：体位・チューブ・便秘・尿閉・口渇への対処が土台。氷水スワブとリップ保湿を1時間ごとに組んだ群は、求めに応じた群より口渇が改善した
- **オピオイドは背景で選ぶ**：不安定な循環・腎肝障害・気管支攣縮ではフェンタニル系。非オピオイドを併用し、呼吸抑制のない範囲で漸増。少量ケタミンでも幻覚が26%対7%に増える
- **処置痛は先に入れる**：胸腔ドレーン抜去なら10分前に氷と鎮痛薬。投与30〜60分後の再評価を同時に指示し、72時間を超えたら減量の計画を立てる

4 鎮静 — 薬の名前より深さと時間

詳しく

事実	数字	使い方
主鎮静薬を替えても同じ	SPICE III 90日死亡29.1%対29.1%、A2Bも優越せず	DEXは転帰ではなく運用上の理由で選ぶ。徐脈・離脱・中止後の上室頻拍を説明する
筋弛緩の害は深鎮静	深鎮静を入れると関連は消え、深鎮静は死亡OR 1.38	筋弛緩を切ったら、その日のうちに浅くする
ABCDEFは用量反応	完全実施で7日死亡HR 0.32、せん妄OR 0.60、抑制OR 0.37	完璧を待たずに始める。A（鎮痛）を先に固める
吸入鎮静はARDSで有害	SESARで90日生存47.1%対55.7%	処理脳波・吸入鎮静・敗血症でのDEX切り替えはルーチンにしない

深鎮静（RASS −2より深い）だった日を毎日カルテに数字で残す。非同調への初手は鎮静の追加ではなく、設定と原因の確認。

5 せん妄・睡眠・離脱

詳しく

- **抗精神病薬はせん妄を短くしない**：MIND-USA・REDUCEとも陰性で、PADIS 2025は推奨を出せていない。予防にも治療にも定時で使わない
- **標的は危険な興奮だけ**：RASS +2〜+4で危害が迫るときに静注ハロペリドール2.5 mg（70歳以上は1.25 mgも可）。CAM-ICUかICDSCが続けて陰性なら止める。ベンゾジアゼピンは例外（アルコール離脱）を除き使わない
- **予防の中身**：ベンゾジアゼピンを外し、SATとSBT、早期離床、家族を入れる（訂正しない・否定しない・議論しない）。身体抑制は指示・記録・家族通知・解除の再評価時刻を残す。退室時に「何が見えていましたか」と聞く
- **睡眠**：鎮静は睡眠ではない。清明ならRCSQ、それ以外は看護観察で測る。処置をまとめ、アラームを耳元から離す
- **離脱**：オピオイド72時間超で16.7%、DEX 3日以上で64%に徴候。DEXを止めたら24時間は心拍数を見る。アルコール離脱はベンゾジアゼピンを症状に合わせて（固定より必要量100 mg対425 mg）

- [ ] **不穏**にプロポフォールを足す前にCPOT
- [ ] **静かな患者**を「落ち着いている」と読まない
- [ ] **ハロペリドール**を出しっぱなしにしない
- [ ] **「せん妄です」**で精査を止めない

出典：本編の主要文献（PADIS 2018・Focused Update 2025；eCASH ICM 2016；Pun CCM 2019；SPICE III NEJM 2019；A2B JAMA 2025；SESAR JAMA 2025；MIND-USA NEJM 2018；REDUCE JAMA 2018；Wongtangman CCM 2021；Kooken ICM 2025 ほか）。用量・設定は教育目的の記載で、使う前に原著・添付文書・各施設の基準と照合してください。